BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2024-06-19 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 1 de 12. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

HEMOGRAMA COMPLETO
Material:
Sangue Total
Método:
Contagem Automatizada por Citometria de Fluxo Fluorescente
Valores de referência
Adultos > 16 Anos
- Masculino
Hemacias em milhoes
5,28
mm3
4,30 - 5,70
Hemoglobina
14,6
g/dL
13,5 - 17,5
Hematocrito
42,8
%
39,0 - 50,0
V.C.M
81,1
fL
81,0 - 95,0
H.C.M
27,7
pg
26,0 - 34,0
C.H.C.M
34,1
g/dL
31,0 - 36,0
R.D.W
15,3
%
11,8 - 15,6
LEUCOGRAMA
Relativo (%)
(mm³)
Leucocitos
8.800
3500 - 10500
Blastos
0,0
0
0
Promielocitos
0,0
0
0
Mielocitos
0,0

0
0
Metamielocitos
0,0
0
0
N. Bastoes
0,0
0
até 840
N. Segmentados
49,0
4.312
1700 - 8000
Eosinofilos
3,0
264
50 - 500
Basofilos
0,0
0
0 - 100
Monocitos
10,0
880
300 - 900
Linfocitos
38
3.344
900 - 2900
Plaquetas
205.000
150.000 - 450.000
Observacoes
Ausencia de alteracoes morfologicas dignas de nota
Data/hora coleta:
19/06/2024 - 07:54:39
Data/hora liberação:
19/06/2024 - 10:41:19

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2024-06-19 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 2 de 12. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

GLICOSE JEJUM
Material :
Soro
Metodo :
Glicose Oxidase- GOD-Trinder
RESULTADO:
71
mg/dL
Valor de
Referência:
60 a 99 mg/dL - Glicemia de Jejum normal
100 a 125 mg/dL - Glicemia de Jejum alterada
= OU > a 126 mg/dL - Criterio diagnostico para o Diabetes Mellitus, sendo necessaria confirmacao em nova amostra, num dia subsequente.
Especificacoes da Qualidade Analitica:
Coeficiente de Variacao Biologica Intra-Individual: 5,6%
Erro Total Permitido:.....: 6,96%
FONTE: James Westgard - EUA
VALOR DE REFERENCIA PARA GESTANTES (2º e 3º TRIMESTRE DE GESTACAO):
Menor que 92 mg/dL
1º trimestre de gestacao: seguir os valores de referencia para a populacao geral
OBSERVAÇAO: A ADA (American Diabets Association) e o grupo de estudo HAPO americano, estabeleceram no ano de 2008, os novos criterios para o diagnostico de Diabetes gestacional. As gestantes devem ser submetidas ao Teste oral de Tolerancia a Glicose (TOTG), entre a 24a e 28a semanas de gestaçao, com 75 gramas de Glicose Anidra, dosagens nos tempos:Jejum, 1 hora pos sobrecarga e 2 horas pos sobrecarga. Um ou mais valores alterados determinam o diagnostico de diabetes gestacional.
Nota: O achado de glicemia casual (sem cumprir o tempo exigido para o jejum) superior ou igual a 200 mg/dL, e criterio diagnostico. Neste caso, tambem e necessario a confirmaçao em nova amostra, num dia subsequente.
Fonte: ADA (American Diabetes Association). Classification and Diagnosis of Diabetes: Standands of Medical care in Diabetes - 2019.
Anteriores:
Data/Hora Coleta:
19/06/2024 - 07:54:39
Data/Hora Liberacao:
19/06/2024 - 13:38:56

09/12/22
08:11:59
05/09/23
08:11:11
12/03/24
07:10:00
19/06/24
07:54:39
0
50
100
150
200
250 168

99 67 71

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2024-06-19 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 3 de 12. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

LIPIDOGRAMA
Material:
Soro
Tempo de Jejum:
12
Horas.
COLESTEROL TOTAL
Método:
Colorimetrico (Enzimatico-Trinder)
RESULTADO:
142
mg/dL
VR:
Valores Referenciais Desejáveis (com ou sem Jejum):
Para adultos acima de 20 anos: Inferior a 190 mg/dL
Para Crianças e Adolescentes: Inferior a 170 mg/dL
Especificacoes da Qualidade Analitica:
Coeficiente de Variacao Biologica Intra-Individual: 5,95%
Erro Total Permitido.....: 9,01%
FONTE: James Westgard - EUA
Nota:
A interpretação clínica dos resultados deverá levar em consideração o motivo da indicação
do exame, o estado metabólico do paciente e estratificação do risco para estabelecimento
das metas terapêuticas.
"Valores de Colesterol Total maior ou igual a 310 mg/dl em adultos (a partir de 20 anos), ou
maior ou igual a 230 mg/dL (para paciente até 19 anos) podem ser indicativos de
Hipercolesterolemia Familiar (HF), se excluídas as dislipidemias secundárias.
Fonte: Consenso Brasileiro para a Normatização da Determinação Laboratorial do Perfil Lipídico (SBPC/ML;
SBC; SBEM; SBD; SBAC) - 2016.
COLESTEROL NÃO-HDL
Método:
Cálculo baseado no Colesterol Total e HDL Colesterol
RESULTADO:
105
mg/dL
VR:
Valor de alvo terapeutico sugerido para categoria de risco cardiovascular estimado pelo medico
solicitante para adultos acima de 20 anos:
Categoria de Risco Meta (com ou sem jejum) mg/dL
Risco Baixo.....Inferior a 160
Risco Intermediário...Inferior a 130
Risco Alto .....Inferior a 100
Risco Muito Alto.....Inferior a 80
NOTA:
O Consenso Brasileiro para a Normatizacao de Determinação Laboratorial do Perfil Lipidico,
recomenda a utilização do parâmetro Colesterol Não-HDL,resultante do calculo baseado no
Colesterol Total e HDL Colesterol.

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2024-06-19 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 4 de 12. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

COLESTEROL HDL
Método:
Colorimetrico (Acelerador-Detergente Seletivo)
RESULTADO:
37
mg/dL
VR:
Valores referenciais Desejáveis:
Para Adultos Acima de 20 anos:
Com ou Sem Jejum: Superior a 40 mg/dL
Para Crianças e Adolescentes:
Com ou Sem Jejum: Superior a 45 mg/dL
Fonte: Consenso Brasileiro para Normatização da Determinação Laboratorial do Perfil
Lipidico (SBPC/ML; SBC; SBEM; SBD; SBAC) - 2016.
Especificacoes da Qualidade Analitica:
Coeficiente de Variacao Biologica Intra-Individual: 7,3%
Erro Total Permitido.....: 11,3%
Fonte: James Westgard (EUA

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2024-06-19 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 5 de 12. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

COLESTEROL LDL
Método:
Calculo baseado na formula de Martin e Cols.
RESULTADO:
73
mg/dL
VR:
Valor de alvo terapêutico sugerido para categoria de risco cardiovascular estimada pelo médico solicitante para adultos acima de 20 anos:
Categoria de Risco Meta (com ou sem jejum) mg/dL
Risco Baixo.....Inferior a 130
Risco Intermediario.....Inferior a 100
Risco Alto.....Inferior a 70
Risco Muito Alto.....Inferior a 50
Valores de Referencia Desejáveis para Crianças e Adolescentes:
Com ou sem Jejum : Inferior a 110 mg/dL
Nota:
* Segundo o novo Consenso Brasileiro, os valores de referência para o colesterol LDL foram substituidos pelos valores de meta terapêutica, estratificados de acordo com o risco cardiovascular calculado.
* A interpretação clínica dos resultados deverá levar em consideração o motivo da indicação do exame, o estado metabólico do paciente e estratificação do risco para estabelecimentos das metas terapêuticas.
* Fonte: Consenso Brasileiro para Normatização da Determinação Laboratorial do Perfil Lipidíco (SBPC/ML; SBC; SBEM; SBD; SBAC) - 2016.
* Os critérios para estabelecimento da categoria de risco cardiovascular do paciente encontram-se disponíveis no site:http://departamentos.cardiol.br/sbc-da/2015/CALCULADORAER2017/index.html
Especificações da Qualidade Analítica:
Coeficiente de Variação Biológica Intra-Individual: 7,8%
Erro Total Permitido.....: 11,9%
Fonte: James Westgard (EUA)

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2024-06-19 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 6 de 12. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

COLESTEROL VLDL
Método:
Calculo baseado na formula de Martin e Cols.
RESULTADO:
32
mg/dL
VR:
Para o teste realizado não dispomos de valor de referência, ficando a critério do médico solicitante sua interpretação.
Nota:
*Segundo o novo Consenso Brasileiro, não há mais valores de referência para a fração VLDL do colesterol.
* A interpretação clínica dos resultados devera levar em consideração o motivo da indicação do exame, o estado metabólico do paciente e estratificação do risco para estabelecimento das metas terapêuticas.
* Fonte: Consenso Brasileiro para a Normatização da Determinação Laboratorial do Perfil Lipídico (SBPC/ML; SBC; SBEM; SBD; SBAC) - 2016.
Especificações da Qualidade Analítica:
Coeficiente de variação biológica Intra-Individual:
Erro total Permitido .....:
Fonte: James Westgard (EUA)

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2024-06-19 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 7 de 12. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

TRIGLICERIDES
Método:
Colorimetrico (Enzimatico-Trinder)
RESULTADO:
218
mg/dL
VR:
Valores referenciais Desejáveis:
Para Adultos acima de 20 anos:
Com Jejum de 12 horas: Inferior a 150 mg/dL
Sem Jejum ou jejum inferior a 12 horas: Inferior a 175 mg/dL
Para Crianças e Adolescentes:
De 0 a 9 Anos (Com jejum de 12 horas): Inferior a 75 mg/dL
(Sem Jejum ou jejum inferior a 12 horas): Inferior a 85 mg/dL
De 10 a 19 anos (Com jejum de 12 horas): Inferior a 90 mg/dL
((Sem Jejum ou jejum inferior a 12 horas): Inferior a 100 mg/dL
* A interpretação clínica dos resultados devrá levar em consideração o motivo da indicação do exame, o estado metabólico do paciente e estratificação do risco para estabelecimento das metas terapêuticas.
* Quando os níveis de triglicérides estiverem acima de 440 mg/dL (sem jejum) sugere-se nova determinação do triglicérides com jejum de 12 horas.
* Fonte: Consenso Brasileiro para a Normatização da Determinação Laboratorial do Perfil Lipídico (SBPC/ML; SBC; SBEM; SBD; SBAC) - 2016.
Especificações da Qualidade Analítica:
Coeficiente de variação Biológica Intra-Individual: 19,9%
Erro Total Permitido.....: 25,9%
Fonte: James Westgard (EUA)
Data/hora coleta:
19/06/2024 - 07:54:39
Data/Hora liberação:
19/06/2024 -
13:38:56

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2024-06-19 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 8 de 12. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

CREATININA SERICA
Material :
Soro
Metodo :
Cinetico UV
RESULTADO
1,51
mg/dL
Valor de
Referencia :
HOMENS INFERIOR A 50 ANOS 0,84 A 1,25 mg/dL
HOMENS SUPERIOR A 50 ANOS 0,81 A 1,44 mg/dL
MULHERES 0,66 A 1,09 mg/dL
RECEM NASCIDOS 0,5 A 1,2 mg/dL
INFANTIL 0,4 A 0,7 mg/dL
CRIANCA 0,5 A 1,2 mg/dL
ESTIMATIVA DA TAXA DE FILTRACAO
GLOMERULAR(eTFG)
57
ml/min/1,73 m2
Valor de
Referencia :
SE AFRO-BRASILEIRO
ESTIMATIVA DA TAXA DE FILTRACAO
GLOMERULAR(eTFG)
49
ml/min/1,73 m2
Valor de
Referencia :
SE CAUCASIANO
Adulto maior de 18 anos: > 90 mL/min/1,73 m2
Adulto menor de 18 anos: Não se aplica
NOTA:
- Valores acima de 90 mL/min/1,73m2 são liberados como superior a
90 mL/min/1,73m2.
- Após os 40 anos de idade, espera-se uma redução de cerca de 1 mL/min
do Ritmo de Filtração Glomerular (RFG) por ano.
- A estimativa do RFG não deve ser utilizada em indivíduos hospitalizados
com concentrações de creatinina instáveis, principalmente pacientes com
Insuficiência Renal Aguda.
- O uso da estimativa de RFG também não é recomendado em indivíduos com
dietas vegetarianas ou que fazem uso de suplementos de creatina,
em extremos de massa muscular (amputados, paraplégicos, desnutridos,
fisiculturistas), e em gestantes.
- Fonte da Fórmula CKD-EPI 2021: Miller WG et al. National Kidney
23/06/23
07:30:00
05/09/23
08:11:11
12/03/24
07:10:00
19/06/24

07:54:39
0
0,5
1
1,5
2 1,30
1,56 1,48 1,51

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2024-06-19 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 9 de 12. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

Foundation Laboratory Engagement Working Group Recommendations for Implementing the CKD-EPI 2021 Race-Free Equations for Estimated Glomerular Filtration Rate: Practical Guidance for Clinical Laboratories. Clin Chem. 2022:68(4):511-520.
- O uso recente de dipirona podem ocasionar discreta redução nos níveis de creatinina dosada pelo método Enzimático.
Data/Hora Coleta:
19/06/2024 - 07:54:39
Data/Hora Liberacao:
19/06/2024 - 13:50:24

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2024-06-19 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 10 de 12. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

SÓDIO
Material :
Soro
Metodo :
ION SELETIVO
RESULTADO
137
mEq/L
Valor de
Referencia :
135 a 145 mEq/L
Especificacoes de Qualidade Analitica:
Coeficiente de Variacao Biologica Intra-Individual: 0,6%
Erro Total Permitido.....: 0,73%
FONTE: James Westgard - EUA
Data/Hora Coleta:
19/06/2024 - 07:54:39
Data/Hora Liberacao:
19/06/2024 - 13:38:56

POTASSIO
Material :
Soro
Metodo :
ION SELETIVO
RESULTADO
4,2
mEq/L
Valor de
Referencia :
3,9 5,0 mEq/L
Especificacoes de Qualidade Analitica:
Coeficiente de Variacao Biologica Intra-Individual: 4,6%
Erro Total Permitido.....: 5,61%
FONTE: James Westgard - EUA
Data/Hora Coleta:
19/06/2024 - 07:54:39
Data/Hora Liberacao:
19/06/2024 - 13:50:24

20/07/15
08:27:00
19/06/24
07:54:39
100
120
140
160
180
144 137
15/12/14
09:22:53

20/07/15
08:27:00
23/06/23
07:30:00
05/09/23
08:11:11
12/03/24
07:10:00
19/06/24
07:54:39
3
4
5
6
7
4,7 4,1
4,7 4,4 3,9 4,2

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2024-06-19 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 11 de 12. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

ACIDO URICO
Material :
Soro
Metodo :
Colorimetrico (Enzimatico-Trinder)
RESULTADO
5,3
mg/dl
Valor de
Referencia :
HOMENS 3,5 A 7,2 mg/dL
MULHERES 2,6 A 6,0 mg/dL
Especificacoes da Qualidade Analitica:
Coeficiente de Variacao Biologica Intra-Individual: 8,6%
Erro Total Permitido.....: 11,97%
FONTE: James Westgard - EUA
NOTA:
- Pacientes em tratamento para gota, recomenda-se níveis séricos de ácido urico
abaixo de 6 mg/dL.
Data/Hora Coleta:
19/06/2024 - 07:54:39
Data/Hora Liberacao:
19/06/2024 - 13:50:24

MICROALBUMINURIA
Material :
Urina Recente
Metodo :
TURBIDIMETRIA
Resultado:
6,74
mg/g creatinina
Valor de
Referencia :
Inferior a 30 mg/g creatinina.
Nota:
- Valores falsamente baixos podem ocorrer em pacientes com macroproteinuria.
Data/Hora Coleta:
19/06/2024 - 07:54:39
Data/Hora Liberacao:
19/06/2024 - 14:35:22

23/06/23
07:30:00
05/09/23
08:11:11
12/03/24
07:10:00
19/06/24
07:54:39
2
4

6
8
10
6,8
7,6 5,9 5,3

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2024-06-19 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 12 de 12. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

HEMOGLOBINA GLICADA (HBA1C)
Material :
Sangue Total
Metodo :
HPLC (CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA PERFORMANCE)
RESULTADO:
6,6
%
Valor de referência:
MENOR QUE 5,7%
DIABETES MELLITUS:
PRÉ-DIBETES - 5,7% A 6,4%
DIAGNÓSTICO - IGUAL OU MAIOR QUE 6,5%
BOM CONTROLE - MENOR QUE 7%
GLICEMIA MÉDIA ESTIMADA-
RESULTADO:
142,7
mg/dL
Valor de referência:
NOTA:
- O diagnóstico de diabetes mellitus deve ser confirmado pela repetição do teste em outro dia, a menos que haja hiperglicemia inequívoca com descompensação metabólica aguda ou sintomas clássicos de diabetes mellitus. American Diabetes Association. Diabetes Care, Vol. 34, hemoglobina S. 1, January 2011. O mÈtodo utilizado nesta dosagem de glicada esta certificado pelo NGSP (National Glycohemoglobin Standardization Program-USA).
- O valor da glicemia média estimada não deve ser utilizado na avaliação de indivíduos não diabéticos.
Data/Hora Coleta:
19/06/2024 - 07:54:39
Data/Hora Liberacao:
19/06/2024 - 18:01:37